

AIP は病理学的にも ARDS と同様にびまん性肺胞傷害（diffuse alveolar damage : DAD）を呈し重篤であるが、完全寛解もありうる疾患であり、慢性経過をたどる特発性肺線維症（idiopathic pulmonary fibrosis : IPF）とは区別される。AIP の症例が慢性化し、IPF に移行することはないと考えられている³⁾。

平均年齢は 50～60 歳であるが、幅広い年齢で発症しうる。性差はなく、喫煙との関係も認められていない。

症候・身体所見

数日から数週間で急速に乾性咳嗽、呼吸困難が進行する。中には 1～2 ヶ月の経過で進行する症例も経験される。入院時、頻呼吸、低酸素血症を呈する場合が多く、発熱は約半数に認める。全身倦怠感や筋肉痛、関節痛を認めることもある。身体所見では胸部聴診にて捻髪音を聴取するが、通常パチ指は認めない。

診断・検査

a 一般的な検査

白血球増加、血沈の亢進、CRP 増加、LDH 上昇、低酸素血症などを認める。KL-6、SP-A、SP-D などの上昇を認めるが、特異性はない。

b 呼吸機能検査

拘束性換気障害を呈し、肺活量の低下や拡散能障害がみられるが、検査が困難な場合も少なくない。

c 気管支肺胞洗浄（bronchoalveolar lavage : BAL）

さまざまな程度的好中球増加やリンパ球増加、肺出血などがみられるが、補助診断としての意味合いが強く、急性好酸球性肺炎や肺感染症との鑑別に有用である。

d 画像所見

胸部 X 線写真では両側性びまん性のすりガラス陰影や融合性浸潤影が認められる（図 3）。胸部 HRCT では両側肺野に対称性に広がる濃度上昇域がみられ、下肺野優位、背側優位に広がる場合が多い。すりガラス陰影に加え、濃い均等性陰影（airspace consolidation）が認められ、air bronchogram が観察される場合もある（図 4）。典型的な蜂巣肺所見は認めない。

HRCT 所見と病理所見とを対比した報告では、病理学的に線維芽細胞増殖期や線維化期になるに従い、牽引性気管支拡張（traction bronchiectasis）を認め、その広がりや予後不良因子となると報告されている⁸⁾。

e 病理検査

DAD の病理所見は、①びまん性分布、②時相は均一、③器質化線維層による肺胞隔壁肥厚、④肺胞腔の器質化（斑状あるいはびまん性）、⑤硝子膜に要約される（図 5）。

発症時期によって浸出期、器質化期（線維芽細胞増

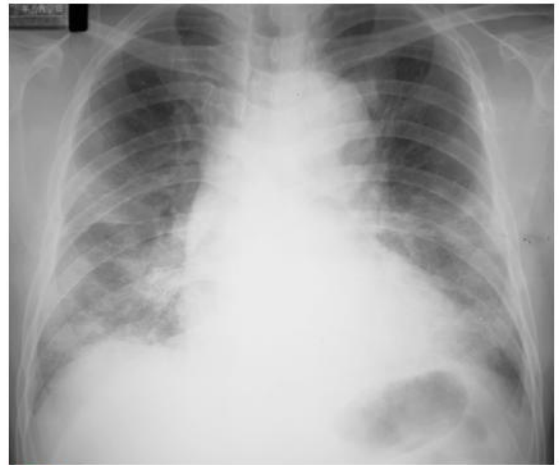


図 3 AIP の胸部 X 線写真

両側、下肺野優位にすりガラス陰影や融合性浸潤影を認める。

殖期)、線維化期に分類されるが、AIP は主に器質化期の所見を呈し、一般に硝子膜形成に乏しい。

f 鑑別診断

鑑別疾患としてはウイルス肺炎、心不全、ARDS、AIP 以外の原因不明の急速進行性間質性肺炎（病理所見としては器質化肺炎パターンや非特異性間質性肺炎パターン⁹⁾、急性好酸球性肺炎、急性過敏性肺炎、膠原病（特に抗 MDA5 抗体陽性の無筋症性皮膚筋炎）に伴う間質性肺炎などがある。IPF が診断されていない段階での急性増悪は AIP と鑑別が難しい場合がある。

治療と予後

a 治療

確立した治療法はなく、一般的な治療を解説する³⁾。

i) 副腎皮質ステロイド薬および免疫抑制薬

a) ステロイド大量療法

パルス療法（methylprednisolone 1,000 mg の 3 日間点滴静注、1 週間間隔で 1～2 コース、最大 4 コースまで）を行う。

b) ステロイド療法

prednisolone 1～2 mg/kg/day、持続で 2 週間投与、以後漸減する。

c) ステロイドの治療反応性が乏しい場合

ciclosporin や tacrolimus, azathioprine, cyclophosphamide の併用を行う。

ii) その他の治療

エンドトキシン吸着療法（PMX-DHP）が試みられることがある。

iii) 呼吸管理

ARDS の呼吸管理に準ずる（p377～378 参照）。

b 予後

死亡率は 40～90% と高いが、完全回復も期待しう